

TEMA 6.14 • INFECTOLOGÍA

Exantemas – Primera Parte

PERFIL EUNACOM 1.05.1.014
Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Exantemas Infecciosos — Parte I

> Regla general: Si es viral → tratamiento **sintomático**. El diagnóstico de todos es **clínico**.

Comparativa

TABLA 6.14.1: ENFERMEDAD VS AGENTE				
ENFERMEDAD	AGENTE	EDAD	INICIO DEL RASH	CARACTERÍSTICAS ÚNICAS
Sarampión	Virus del sarampión	Cualquiera (erradicado en Chile)	Cabeza → caudal	Fiebre alta + conjuntivitis + tos. Manchas de Koplik (enatema patognomónico, precede al exantema). Exantema rojo intenso/morbiliforme .
Rubéola	Virus de la rubéola	Cualquiera (erradicado)	Cabeza → caudal	Fiebre baja . Exantema rosado suave . Adenopatías retroauriculares y cervicales posteriores (muy específico). Artralgias.
Eritema Infeccioso (5ª Enfermedad)	Parvovirus B19	Escolares (4-12 años)	Mejillas → EEII/tronco	Eritema malar bilateral = "signo de la cachetada". Luego exantema en encaje/reticular en EEII. Artralgias.
Exantema Súbito (Roseóla / 6ª Enfermedad)	Herpesvirus HHV-6	Lactantes (6m-18m)	Tronco (después de la fiebre)	Fiebre alta (40-41°C) que cede súbitamente → entonces aparece exantema maculopapular raro. Frecuente en convulsiones febriles.

Puntos Clave

- **Sarampión y Rubéola:** Notificación inmediata a SEREMI. En Chile requieren **confirmación con IgM**.

- **Eritema Infeccioso:** Riesgo en embarazada → aborto o muerte fetal (no TORCH propiamente).
- **Exantema Súbito:** No confundir el exantema post-fiebre con alergia a antibiótico si se había iniciado ATB previo.
- Infecciones **erradicadas** en Chile (sarampión, rubéola): buscar extranjeros no vacunados o niños < 1 año sin vacunar.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:
"Lactante de 10 meses presenta fiebre de 40,5°C por 3 días. Al cuarto día la fiebre desaparece y aparece un exantema maculopapular eritematoso en tronco. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:
Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Exantemas - Primera Parte. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- Diagnóstico de exantemas: considerar edad, localización y síntomas acompañantes. Los virales se tratan con paracetamol.
- Sarampión: exantema rojo intenso, fiebre alta, precedido por CONJUNTIVITIS o TOS, manchas de Koplick patognomónicas. Notificación inmediata. Complicaciones: neumonía y encefalitis.
- Rubéola: exantema rosado, fiebre baja, ADENOPATÍAS RETROAURICULARES y cervicales posteriores, artralgias. Riesgo principal: TORCH. Notificación inmediata.
- Eritema infeccioso (parvovirus B19): escolares, SIGNO DE LA CACHETADA (eritema malar) + exantema en encaje. Causa más frecuente de artritis viral en Chile. Riesgo de aborto.
- Exantema súbito (HHV-6): lactantes 6-18 meses, FIEBRE MUY ALTA (40-41°C) que cede y luego aparece exantema. Causa de convulsiones febriles. No confundir con alergia a antibióticos.
- Sarampión y rubéola erradicados en Chile: confirmación con IgM y notificación inmediata obligatorias.
- Fiebre alta: sarampión y exantema súbito. Fiebre baja: rubéola y eritema infeccioso.

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (EXANTEMAS - PRIMERA PARTE)

PREGUNTA 1

Lactante de 10 meses presenta fiebre de 40,5°C por 3 días. Al cuarto día la fiebre desaparece y aparece un exantema maculopapular eritematoso en tronco. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- A) Sarampión
- B) Rubéola
- C) Exantema súbito (roséola)
- D) Eritema infeccioso
- E) Alergia a antibióticos

PREGUNTA 2

Niño de 6 años consulta por eritema intenso en ambas mejillas desde hace 2 días, seguido de un exantema reticular en extremidades. No tiene fiebre significativa. ¿Cuál es el agente etiológico más probable?

- A) Virus del sarampión
- B) Virus rubéola
- C) Parvovirus B19
- D) Virus HHV-6
- E) Streptococcus pyogenes

PREGUNTA 3

Adulto joven extranjero no vacunado consulta por exantema rojo intenso generalizado, fiebre de 39,8°C, conjuntivitis bilateral y tos seca. Al examen se observan lesiones blanquecinas en la mucosa de las mejillas. ¿Cuál es la conducta prioritaria?

- A) Tratamiento con aciclovir endovenoso
- B) Notificación inmediata a la SEREMI y solicitar IgM para sarampión
- C) Iniciar antibióticos empíricos por posible sobreinfección bacteriana
- D) Tratamiento sintomático solamente, sin notificación
- E) Solicitar hemograma y PCR para confirmar etiología viral

RESUMEN: EXANTEMAS - PRIMERA PARTE

Esta clase aborda los exantemas infecciosos, comenzando con generalidades y cubriendo sarampión, rubéola, eritema infeccioso y exantema súbito. Para diagnosticar exantemas hay que considerar la edad, localización del exantema y los síntomas acompañantes. Los exantemas virales se tratan sintomáticamente con paracetamol. El sarampión (erradicado en Chile) produce un exantema rojo intenso morbiliforme, fiebre alta, malestar general y viene precedido por conjuntivitis o tos, con manchas de Koplick patognomónicas. Se notifica inmediatamente. Complicaciones: neumonía y encefalitis. La rubéola produce exantema rosado con fiebre baja, adenopatías retroauriculares y cervicales posteriores, y artralgias. Su riesgo principal es el TORCH en embarazadas. También de notificación inmediata. El eritema infeccioso (quinta enfermedad, parvovirus B19) afecta escolares, inicia con eritema malar (signo de la cachetada) y luego exantema en encaje en extremidades y tronco. Puede producir abortos y artritis viral. El exantema súbito (roséola, sexta enfermedad, virus HHV-6) afecta lactantes de 6-18 meses con fiebre muy alta (40-41°C, causa de convulsiones febriles) que cede y luego aparece el exantema maculopapular. No confundir con alergia a antibióticos.